ENFERMEDAD DE VÍAS BILIARES II

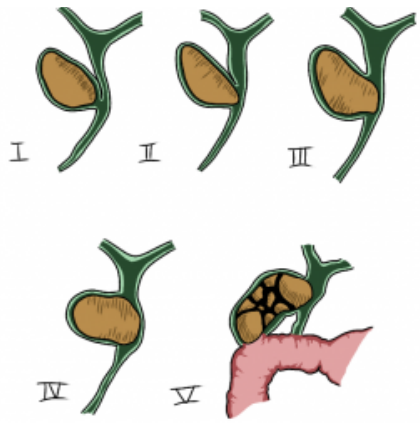
DR. INTI PÉREZ C.

COLECISTITIS AGUDA

- Inflamación de la pared vesicular por obstrucción del cuello/cístico; 90-95% litiásica, 5-10% alitiásica (pacientes críticos).
- Clínica: dolor en hipocondrio derecho >6h que no cede, Murphy positivo, fiebre, leucocitosis 10,000-20,000.
- Cólico biliar vs colecistitis: dolor <6h sin Murphy ni fiebre, vs. dolor >6h con Murphy y fiebre frecuente.
- Tratamiento: colecistectomía laparoscópica temprana (primeras 72h); Tokio 2018 guía la conducta según gravedad (I, II, III).

COLEDOCOLITIASIS

- Cálculo en el colédoco, la mayoría migrados de la vesícula; clínica de colestasis (ictericia, acolia, coluria).
- Tratamiento de elección: CPRE con esfinterotomía.



PÓLIPOS VESICULARES

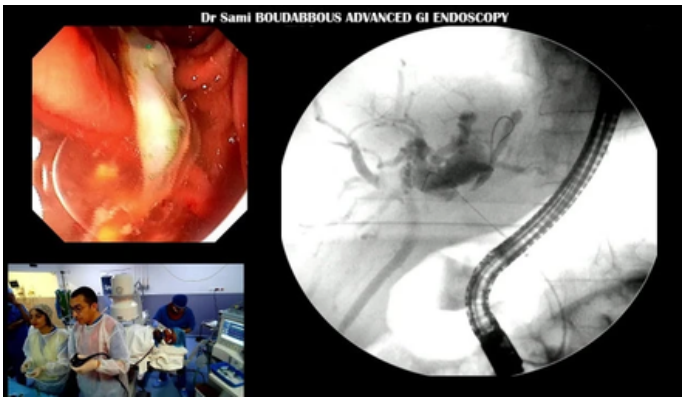
- Se operan los de 1 cm o mayores (pregunta de examen); los menores se vigilan con ultrasonido cada 6-12 meses.

CIRUGÍA DE LA COLELITIASIS

- Colecistectomía laparoscópica: estándar de oro; critical view of safety de Strasberg identifica arteria cística, conducto cístico, bolsa de Hartmann e hilio hepático.
- Asintomáticos que sí se operan: falcémicos (indicación absoluta) y pacientes de cirugía bariátrica (pregunta de examen).
- Otras indicaciones: vesícula en porcelana, cálculos >3cm, pólipos asociados a colangitis esclerosante.

COLANGITIS

- Infección ascendente de la vía biliar con obstrucción; tríada de Charcot (fiebre, dolor en hipocondrio derecho, ictericia); péntada de Reynolds suma hipotensión y alteración de conciencia.
- Tratamiento: drenaje precoz de la vía biliar (piedra angular); CPRE de elección, CPTH o cirugía de rescate si falla.



NEOPLASIAS DE LA VÍA BILIAR

- Colangiocarcinoma: tumor de Klatskin (perihiliar) es el más frecuente (40-60%); marcador CA 19-9.
- Neoplasias periampulares: tratamiento con pancreatoduodenectomía (Whipple); sobrevida a 5 años menor al 10%.

ENFERMEDAD DE VÍAS BILIARES II

DR. INTI PÉREZ C.

COLELITIASIS

- Cálculos en la vesícula; predominio en mujeres >30 años; <20% desarrollará síntomas; con frecuencia hallazgo incidental.
- Diagnóstico: ultrasonido; los asintomáticos en general no se tratan.

ETIOLOGÍA DEL CÓLICO BILIAR

- Impactación transitoria del cálculo en el cístico (o en el colédoco); el dolor nace del espasmo por hipertensión brusca de la vesícula o la vía biliar.

CLÍNICA DEL CÓLICO BILIAR

- Dolor en HCD irradiado a escápula y hombro derecho (signo de Boas); continuo, progresivo, posprandial, <6 h; náuseas y vómitos.
- Sin fiebre, leucocitosis ni ictericia; vesícula no palpable.

TRATAMIENTO DEL CÓLICO BILIAR

- Clínica + ecografía; AINE (elección), antieméticos y antiespasmódicos (butilbromuro de hioscina); cirugía programada.

FISIOPATOLOGÍA DE LA COLECISTITIS

- Cálculo enclavado → contracciones, edema, inflamación e infección; la presión vence el drenaje linfático, luego el venoso y el arterial → isquemia, necrosis y perforación.
- No se perfora de forma automática (más lento que la apendicitis); pus = piocolecisto.

COLECISTITIS ALITIÁSICA

- 5–10%: pacientes críticos, sepsis, quemaduras, trauma, NPT; gramnegativos, estreptococo grupo D, estafilococos, Clostridium.
- 50–80% en estadio avanzado; mortalidad ~40%: tratamiento intensivo con colecistostomía percutánea o cirugía urgente.

COLECISTITIS ENFISEMATOSA

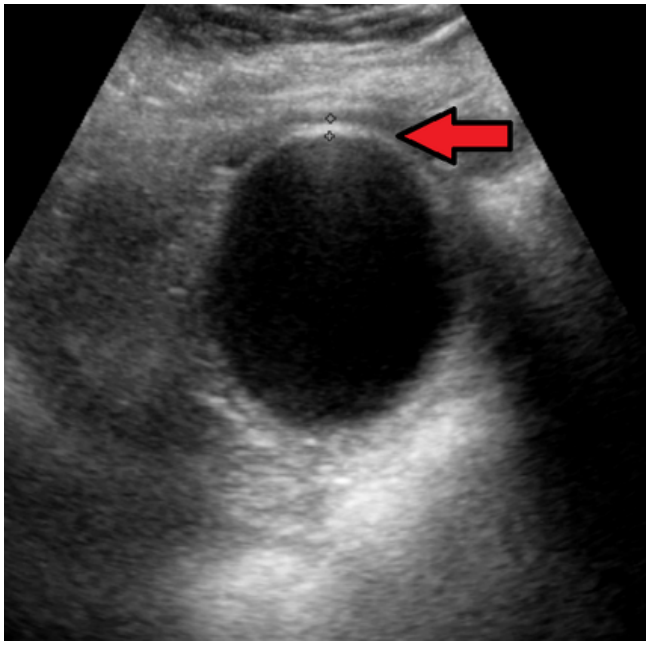
- 1%: varón diabético con enfermedad vascular; Clostridium perfringens; gas en luz y pared; sepsis rápida: colecistectomía inmediata.

LABORATORIO EN COLECISTITIS

- Leucocitosis 10 000–20 000; bilirrubina levemente elevada (>4 mg/dL sugiere coledocolitiasis); fosfatasa alcalina, a veces transaminasas y amilasa.

ULTRASONIDO EN COLECISTITIS

- Pared >4 mm, distensión >4 cm AP, líquido perivesicular, cálculo enclavado en cuello/Hartmann y Murphy ecográfico.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Cardiopatía isquémica, patología péptica, pancreatitis aguda, apendicitis retrocecal y dolores neuromusculares.

MANEJO INICIAL DE LA COLECISTITIS

- Reposo digestivo, hidratación IV, analgesia (no enmascara: el diagnóstico es por imagen), antitérmicos, antieméticos y antiespasmódicos.
- Antibióticos: cefalosporinas, ceftriaxona + metronidazol, amoxicilina-clavulánico o piperacilina-tazobactam.

MANEJO DEFINITIVO DE LA COLECISTITIS

- Colecistectomía laparoscópica temprana (<72 h) en el mismo ingreso; con manejo médico, cirugía electiva a las 8–12 semanas.
- Técnica abierta (subcostal de Kocher) solo si hay que convertir.

TOKIO 2018: GRADO I (LEVE)

- Sin disfunción orgánica: colecistectomía temprana (si alto riesgo, antibióticos y cirugía programada).

ENFERMEDAD DE VÍAS BILIARES II

DR. INTI PÉREZ C.

TOKIO 2018: GRADO II (MODERADA)

- Gangrena, absceso, peritonitis o >18 000 leucocitos: colecistectomía urgente.

TOKIO 2018: GRADO III (GRAVE)

- Disfunción orgánica (creatinina >2, INR >1,5, hipotensión, PaO2/FiO2 <300) o ASA >III: colecistostomía percutánea y colecistectomía laparoscópica programada.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS	CRITERIO	HALLAZGOS
A. INFLAMACIÓN SISTÉMICA	A1	Fiebre >38°C y/o escalofríos
	A2	Leucocitos >10,000/mm³ o <4,000/mm³, o PCR ≥1 mg/dL
B. COLESTASIS	B1	Ictericia (Bilirrubina total ≥2 mg/dL)
	B2	AST, ALT, FA o GGT >1.5 veces el límite superior normal
C. HALLAZGOS POR IMAGEN	C1	Dilatación de la vía biliar
	C2	Evidencia de obstrucción biliar (coledocolitiasis, estenosis, tumor o prótesis obstruida)

INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA	
COLANGITIS SOSPECHADA Un criterio de A + un criterio de B o C	COLANGITIS DEFINITIVA Un criterio de A + un criterio de B + un criterio de C

CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD (TG18)

GRADO III (SEVERA)	GRADO II (MODERADA)	GRADO I (LEVE)
Presencia de disfunción orgánica en cualquiera de los siguientes sistemas: • **Cardiovascular:** hipotensión que requiere vasopresores • **Neurológico:** alteración del estado de conciencia • **Respiratorio:** PaO_2/FiO_2 <300 • **Renal:** creatinina >2.0 mg/dL • **Hepático:** INR >1.5 • **Hematológico:** plaquetas <100,000/mm³ La presencia de CUALQUIERA de estos criterios clasifica al paciente como GRADO III.	Se requieren ≥2 criterios • Leucocitos >12,000 o <4,000/mm³ • Fiebre ≥39°C • Edad ≥75 años • Bilirrubina total ≥5 mg/dL • Albúmina sérica <0.7 veces el límite inferior normal	No cumple criterios de Grado II ni Grado III.

COMPLICACIONES DE LA COLECISTITIS

- Hidrops (vesícula a tensión llena de moco), gangrena y perforación, empiema (cirugía urgente), colecistitis crónica y vesícula en porcelana.

FÍSTULA COLECISTOENTÉRICA

- Hacia duodeno, colon o estómago, con aerobilia; colecistectomía y cierre de la fístula.

ÍLEO BILIAR

- El cálculo pasa por la fístula y obstruye el intestino delgado (íleon terminal); los <2–3 cm pasan espontáneamente; enterotomía proximal y colecistectomía diferida.
- Síndrome de Bouveret: impactación en el duodeno.

CLÍNICA DE LA COLEDOCOLITIASIS

- Asintomática, cólico, ictericia, colangitis o pancreatitis; colestasis (ictericia, acolia, coluria, prurito); sin leucocitosis.
- Ante ictericia o colangitis en un colecistectomizado, pensar en coledocolitiasis residual.

LABORATORIO E IMAGEN EN COLEDOCOLITIASIS

- Bilirrubina directa, FA, GGT y 5-nucleotidasa elevadas.
- US: vía biliar >6 mm; colangio-RM y ecoendoscopia, las mejores diagnósticas; CPRE diagnóstica y terapéutica.

TRATAMIENTO DE LA COLEDOCOLITIASIS

- CPRE con esfinterotomía; si falla, CPTH; exploración quirúrgica transcística o transcoledociana; derivación bilioentérica excepcional.
- Colelitiasis + coledocolitiasis: CPRE preoperatoria y luego colecistectomía.
- Complicaciones: pancreatitis, colangitis, estenosis y cirrosis biliar.

SÍNDROME DE MIRIZZI

- Compresión de la vía biliar por cálculo en infundíbulo/cístico (~1%); requiere hepático común y cístico paralelos.
- Tipo I: compresión; tipo II: fístula colecistocoledociana. Colecistectomía y coledocoplastia sobre tubo de Kehr o derivación bilioentérica.

	Colecistitis crónica	Comprensión extrínseca de la vía biliar principal	Fístula colecistocoledocal			Fístula colecistoentérica
Estadios						
McSherry y otros	1982	Tipo I	Tipo II			
Csendes y otros	1989	Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo IV	
Csendes y otros	2007	Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo IV	Tipo V

COMPLICACIONES DE LA COLECISTECTOMÍA

- Lesión de la vía biliar principal o de la arteria/conducto hepático derecho, fuga del muñón cístico y biloma.

MICROBIOLOGÍA DE LA COLANGITIS

- Vía portal, la más frecuente; E. coli (la más frecuente), Klebsiella, Streptococcus, Enterococcus, Pseudomonas, Proteus; anaerobios Bacteroides y Clostridium; hemocultivos positivos.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE COLANGITIS

- Clínicos: antecedente biliar, fiebre/escalofríos, ictericia, dolor en HCD o epigastrio. Analíticos: respuesta inflamatoria y perfil hepático alterado. Imagen: dilatación de la vía biliar.
- Certeza: Charcot o ≥2 clínicos + analíticos + imagen; sospecha: ≥2 clínicos.

ENFERMEDAD DE VÍAS BILIARES II

DR. INTI PÉREZ C.

MANEJO DE LA COLANGITIS

- Soporte, hidratación y corrección de la coagulación; antibióticos (ampicilina-sulbactam, piperacilina-tazobactam, cefalosporinas de 3.ª/4.ª, quinolonas o carbapenémicos).
- Colecistectomía programada si hay colelitiasis.

INDICACIONES EN EL ASINTOMÁTICO

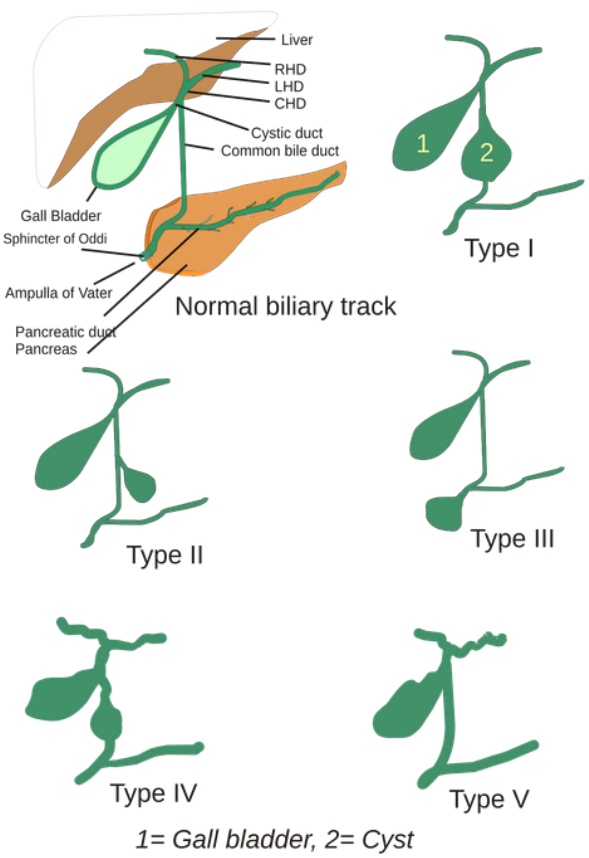
- Anemia hemolítica/falciforme (absoluta), diabetes, bariátrica, trasplantados, NPT crónica; cálculo >3 cm, pólipos con colangitis esclerosante, porcelana (15–20% carcinoma); pancreatitis biliar previa, Y de Roux.

COLANGIOGRAFÍA INTRAOPERATORIA

- Ictericia, hiperbilirrubinemia, pancreatitis biliar resuelta, FA elevada, coledocolitiasis en US o necesidad de definir la anatomía.

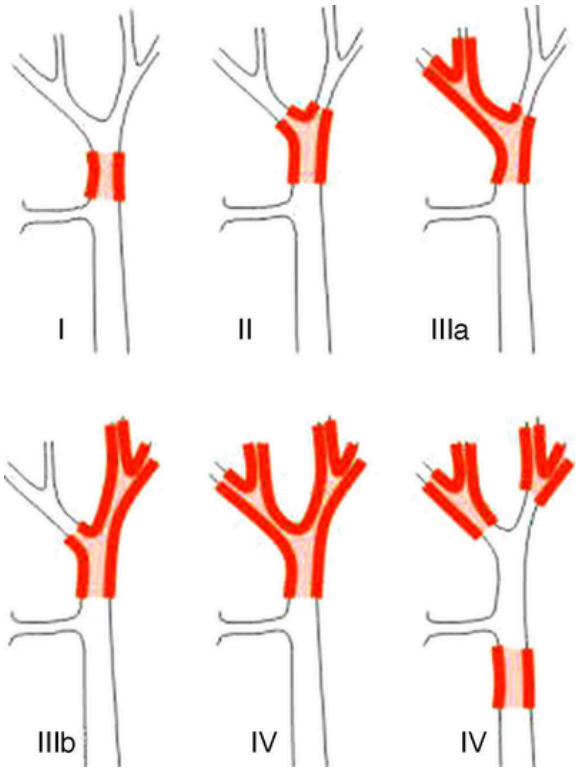
QUISTES DE COLÉDOCO

- Dilatación quística intra/extrahepática; mujeres, niños, asiáticos; Todani (Ia y Ic los más frecuentes); dolor e ictericia, masa en pediatría.
- Alto riesgo de colangiocarcinoma: todos se operan (resección total y reconstrucción intestinal).



CLASIFICACIÓN DE KLATSKIN

- I: debajo de la confluencia; II: llega a la confluencia; IIIA: hepático común + derecho; IIIB: común + izquierdo; IV: confluencia y ambos o multicéntrico.



MANEJO DEL COLANGIOCARCINOMA

- Intrahepático: hepatectomía; extrahepático: resección + reconstrucción bilioentérica; paliativo: drenaje percutáneo o stent por CPRE.